EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 73158
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2023-10-27 14:04:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GUILLERMINA ANTONIET HENRIQUEZ URZUA			RUN	: 10.908.825-0
F.Nac	: 27-06-1964	Edad	: 59 AÑOS, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: AV.LOS TILOS S/N			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-20	Fecha Egreso	: 2023-10-27 14:04:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J90.X-DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. TEP agudo de ramas segmentarias y subsegmentarias lóbulo inferior izquierdo, PESI score 89, CLASE III, Riesgo Intermedio.
2. Derrame pleural masivo derecho / Neumotórax post SEP.
2.1 SEP (20/10/2023-26/10/23) --> Exudado mononuclear
3. Diabetes Mellitus 2 No IR
4. Hipotiroidismo
5. ACV no secuelado
6. Trastorno de Ansiedad generalizada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de DM, Hipotiroidismo, ACV no secuelado en noviembre/2022, derivada desde APS por cuadro de disnea y tos desde 11/10/2023. Se maneja como Bronquitis sin mejoria. Ingresa a SU Hospital de San Carlos, a su llegada normotensa, normocardica, saturando 96% FiO2 21%. Se toma Radiografia de Torax se evidencia pulmon derecho velado. Exs de laboratorio destaca Dimero D: 8962, por sospecha de TEP se administra enoxaparina en dosis terapeutica, se solicita Angiotac de Torax, el cual se logra tomar a las 21:00 hrs, se rescata informe: "Tromboembolismo pulmonar agudo en de ramas segmentarias y subsegmentarias para el lóbulo inferior izquierdo, sin signos de sobrecarga cardíaca derecha. Acentuado derrame pleural derecho. Engrosamiento difuso e irregular de la pleura parietal derecha". PESI SCORE 89 , CLASE III, Riesgo Intermedio. Se solicita evaluacion por medico residente UTI, se indica manejo por cirugia por derrame pleural masivo a derecha. Cirujano de turno instala SEP, se toman muestra de liquido pleural para analisis. Ingresa a UTI para monitorizacion invasiva e inicio de anticoagulacion. Analisis de liquido pleural --> Exudado mononuclear. TAC de Torax 21/10/2023 evidencia Moderado Neumotorax derecho; evaluada por cirujano se configura SEP-Aspirativo. Se logra destete de O2. Completa 5 días con HBPM en dosis plena, se realiza traslape a Dabigatran. Reevaluada por Cirugía 25/10/2023 se retira SEP. Tac de Torax de control 26/10/2023 con Leve hidroneumotorax derecho. ADA 6.8 U/L. Se toma Tac de cerebro, abdomen y pelvis, pendiente informe.
Paciente evoluciona favorablemente, sin requerimiento de O2, por lo que se decide HODOM para continuar manejo con KNT respiratoria. Control y seguimiento con Broncopulmonar .

PLAN DE MANEJO:

Control en 15 dias en CAE Broncopulmonar HSC
Control Poli TACO (Ingreso poli TACO, dejar receta y controles cada 3 meses)

INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM para continuar KNT respiratoria
2. Regimen diabético
3. Dabigatran 150 mg 1 comprimido c/12 hrs vo

4. Omeprazol 20 mg 1 comprimido antes del desayuno vo
5. Bromuro de Ipratropio 2 puff c/6 hrs con aerocamara
6. Atorvastatina 40 mg 1 comprimido por noche vo
7. Levotiroxina 100 ug 1/2 comprimido en ayunas vo
8. Fluoxetina 20 mg 1 comprimido al dia vo
9. Clonazepam 0.5 mg 1/2 comprimido c/12 hrs vo
10. Quetiapina 25 mg 1/2 comprimido por noche vo
11. Control en 15 dias en CAE Broncopulmonar HSC
12. Control Poli TACO (Ingreso poli TACO, dejar receta y controles cada 3 meses)

EXÁMENES Y RESULTADOS

AngioTAC de Torax (19/10/2023): Tromboembolismo pulmonar agudo en de ramas segmentarias y subsegmentarias para el lóbulo inferior izquierdo, sin signos de sobrecarga cardíaca derecha. Acentuado derrame pleural derecho. Engrosamiento difuso e irregular de la pleura parietal derecha.

TAC de Torax (21/10/2023): Moderado neumotorax derecho. Tubo de drenaje pleural, con actual leve a moderado derrame pleural derecho. Focos de condensacion e imagenes nodulares en el parenquima pulmonar derecho parcialmente expandido, con areas atelectasicas. Engrosamiento septal liso a derecha, posiblemente debido a edema pulmonar exvacuo.Pequeños focos de relleno alveolar apicales izquierdos. Colelitiasis.

TAC de Torax (26/10/2023): Leve hidroneumotórax derecho. Múltiples nódulos Y pequeñas las pulmonares derechas, las que se sugiere estudiar de manera dirigida. Signos sugerentes de linfangitis carcinomatosa en el pulmón derecho. Colelitiasis. Nefrolitiasis bilateral.

Cultivo liquido pleural (-)
ADA 6.8 U/L

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

DANIELA VASQUEZ BAHAMONDEZ
MEDICO TRATANTE
16516335-4

JEFE SERVICIO